

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

INVENTARIO DE TEMPERAMENTO Y CARÁCTER REVISADO (TCI-R)

Eje III: Personalidad • Modelo Psicobiológico de Cloninger: 4 Temperamentos y 3 Caracteres

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Inventario de Temperamento y Carácter Revisado (TCI-R).
Nombre Original	Temperament and Character Inventory-Revised (TCI-R; Cloninger, 1999).
Autor Original	Dr. C. Robert Cloninger, M.D. (Washington University School of Medicine in St. Louis, EE.UU.).
Adaptación Hispana	Gutiérrez-Zotes et al. (2004); Bayón et al. (TEA Ediciones, Madrid, España).
Eje Clínico y Constructo	Eje III: Personalidad. Modelo psicobiológico integral (dimensiones neuroquímicas y sociocognitivas).
Tipo de Instrumento	Autoinforme de 240 ítems Likert de 5 puntos (1 a 5) + 5 ítems de control de consistencia.
Población y Rango	Adolescentes (≥ 16 años) y adultos en población clínica, psiquiátrica y general.
Tiempo de Administración	35 a 50 minutos de autoadministración supervisada.
Régimen de Licencia	Bajo licencia de autor y comercialización editorial (TEA Ediciones / Cloninger). Nivel C.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: EL MODELO PSICOBIOLOGICO DE CLONINGER

El **Modelo Psicobiológico de la Personalidad** de Cloninger (1993, 1999) integra la neurobiología funcional monoaminérgica con el desarrollo ontogenético sociocognitivo. El modelo postula una doble estructura cualitativa:

- **Temperamento (4 Dimensiones Biológicas):** Disposiciones afectivas tempranas, automáticas y genéticamente determinadas ($h^2 \approx 50\%$) mediadas por redes cerebrales corticosubcorticales específicas:
 1. *Búsqueda de Novedad (NS)*: Activación conductual ante estímulos novedosos (vía dopaminérgica meso-límbica).
 2. *Evitación del Daño (HA)*: Inhibición conductual ante señales aversivas o incertidumbre (vía serotoninérgica).
 3. *Dependencia de la Recompensa (RD)*: Mantenimiento de la conducta por reforzamiento social (vía noradrenérgica).
 4. *Persistencia (P)*: Perseverancia en metas a pesar de la fatiga o el cese de recompensa inmediata (red frontoestriatal).
- **Carácter (3 Dimensiones Sociocognitivas):** Maduración del autoconcepto, modulación volitiva y aprendizaje propositivo a lo largo del ciclo vital: *Autodirección (SD)*, *Cooperación (CO)* y *Autotrascendencia (ST)*.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS (7 DIMENSIONES CLÍNICAS)

Dimensión Psicométrica	Nº Ítems	Subescalas / Facetas Evaluadas (TCI-R)
Búsqueda Novedad (NS)	35 ítems	NS1: Excitabilidad exploratoria; NS2: Impulsividad; NS3: Extravagancia; NS4: Desorden.
Evitación del Daño (HA)	33 ítems	HA1: Preocupación pesimista; HA2: Miedo a la incertidumbre; HA3: Timidez; HA4: Fatigabilidad.
Depend. Recompensa (RD)	30 ítems	RD1: Sentimentalismo; RD2: Apertura a la comunicación; RD3: Apego; RD4: Dependencia.
Persistencia (P)	35 ítems	P1: Ansia de triunfo; P2: Tenacidad; P3: Esfuerzo continuo; P4: Perfeccionismo.
Autodirección (SD)	40 ítems	SD1: Responsabilidad; SD2: Propósito de vida; SD3: Capacidad de recursos; SD4: Autoaceptación.
Cooperación (CO)	36 ítems	CO1: Aceptación social; CO2: Empatía; CO3: Compasión; CO4: Principios morales integrados.
Autotrascendencia (ST)	26 ítems	ST1: Autoolvido; ST2: Identificación transpersonal; ST3: Conciencia espiritual / mística.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN CLÍNICA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO PSICOMÉTRICO EN ESPAÑA / LATAM

La validación española (Gutiérrez-Zotes et al., 2004; $N = 650$, y baremaciones clínicas ampliadas de TEA) documenta una sólida fiabilidad métrica:

Dimensión / Escala	Consistencia (Alfa)	Evidencia Psicométrica y Baremación Española
Temperamento (NS, HA)	NS: 0.82 • HA: 0.87	Elevada coherencia interna; HA se consolida como marcador robusto de vulnerabilidad ansiosa.
Temperamento (RD, P)	RD: 0.78 • P: 0.85	P muestra alta estabilidad métrica superando la escala dicotómica original del TCI clásico.
Carácter (SD, CO)	SD: 0.87 • CO: 0.85	Excelente consistencia; constituyen el núcleo diagnóstico universal de salud mental.
Carácter (ST)	ST: 0.86	Capacidad adecuada para medir espiritualidad secular y madurez transpersonal.
Estabilidad Test-Retest	$r = 0.80 - 0.86$	Demostrada a 6 y 12 meses; el temperamento exhibe mayor estabilidad longitudinal.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN, CONTROL DE VALIDEZ Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

• **Puntuación de Ítems:** Escala Likert de 5 puntos: Totalmente falso (1), Probablemente falso (2), Ni verdadero ni falso (3), Probablemente verdadero (4), Totalmente verdadero (5). Se invierten las claves oficiales.

• **Índices de Validez del Protocolo:**

1. *Índice de Consistencia Interna:* Incluye 5 pares de reactivos idénticos o cuasi-idénticos repetidos. Discrepancias sistemáticas en > 2 pares invalidan el perfil.
2. *Omisiones:* Un protocolo con más de 10 omisiones totales se considera no computable.

• **Conversión Normativa:** Las puntuaciones directas de cada una de las 7 dimensiones se transforman a **Puntuaciones T** (Media = 50, DT = 10) basadas en baremos españoles diferenciados por sexo y grupo etario.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y DIAGNÓSTICO DE TRASTORNO

Estratificación	Rango T	Nivel del Rasgo	Significación Clínica y Diagnóstica en el Modelo Cloninger
Muy Bajo	$T < 35$	Déficit extremo	Falla estructural; si ocurre en SD o CO, es marcador casi inequívoco de patología.
Bajo	$35 \leq T \leq 44$	Rango vulnerable	Madurez frágil o inhibición disposicional; predisposición a conflicto vincular.
Medio / Normal	$45 \leq T \leq 55$	Población general	Equilibrio funcional y adaptativo en la interacción persona-ambiente.
Alto	$56 \leq T \leq 65$	Rasgo acentuado	Estilo característico de afrontamiento; define fortalezas y sesgos cognitivos.
Muy Alto	$T \geq 66$	Expresión clínica extrema	Hipertrofia disposicional (ej. HA extrema: parálisis fóbica; NS extrema: temeridad).

EL MARCADOR UNIVERSAL DE TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD (SD < 40T Y CO < 40T):

En el modelo de Cloninger, la existencia de un Trastorno de la Personalidad (TP) viene definida universalmente por el fracaso en la maduración del Carácter (**Autodirección < 40T** y **Cooperación < 40T**). El perfil de Temperamento (NS, HA, RD) determina el 'subtipo' sindrómico específico (Grupo A, B o C del DSM).

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO CLÍNICO DE CLONINGER PARA DIAGNÓSTICO Y ABORDAJE INTEGRAL

PROTOCOLO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO BASADO EN TEMPERAMENTO Y CARÁCTER:

- **Paso 1 (Cribado de Trastorno de Personalidad):** Evaluar las dimensiones de Carácter. Si $SD < 40$ y $CO < 40$, confirmar presencia de trastorno de personalidad estructurado. Evaluar severidad en función del déficit en SD.
- **Paso 2 (Tipificación del Estilo Temperamental):** Analizar la tríada NS/HA/RD:
 - *Alta NS + Alta HA + Baja RD:* Configuración explosiva-inestable (perfil Borderline / Límite).
 - *Alta NS + Baja HA + Baja RD:* Perfil antisocial predatorio.
 - *Baja NS + Alta HA + Alta RD:* Perfil dependiente-evitativo (fóbico ansioso).
- **Paso 3 (Adaptación del Tratamiento al Temperamento):** El temperamento difícilmente cambia; debe gestionarse ambiental y farmacológicamente (ej. antidepresivos o moduladores de impulsos según equilibrio monoaminérgico).
- **Paso 4 (Psicoterapia Centrada en el Carácter):** Orientar los objetivos psicoterapéuticos al crecimiento volitivo de la Autodirección (asunción de responsabilidad) y Cooperación (flexibilización empática).

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN DESREGULACIÓN EMOCIONAL Y CONDUCTAS DE RIESGO

Identificación: Varón de 26 años, derivado por psiquiatría tras episodios reiterados de policonsumo de sustancias, conducción temeraria, relaciones de pareja caóticas y frecuentes ingresos en urgencias por crisis de angustia e ideación autolítica no letal.

Perfil Psicométrico TCI-R (Línea Base):

- **Temperamento:** *Búsqueda de Novedad (NS)* = 74T (Extrema impulsividad y desorden); *Evitación del Daño (HA)* = 69T (Ansiedad anticipatoria y fatigabilidad); *Dependencia de la Recompensa (RD)* = 31T (Apego evitativo y frialdad defensiva); *Persistencia (P)* = 28T (Abandono prematuro de proyectos).
- **Carácter:** *Autodirección (SD)* = 30T (Severa inmadurez del self, victimismo externo); *Cooperación (CO)* = 34T (Intolerancia e incapacidad empática); *Autotranscendencia (ST)* = 46T (Promedio).

Formulación Clínica: Trastorno Límite de la Personalidad caracterizado por conflicto biológico entre búsqueda de estimulación (NS=74) e inhibición ansiosa (HA=69), agravado por el colapso ejecutivo de la autodirección (SD = 30T). n **Intervención y Evolución (14 meses):** Se aplicó Terapia Dialéctico-Conductual (DBT) combinada con estabilizador del ánimo. El tratamiento focalizó en habilidades de tolerancia al malestar y fortalecimiento de metas vocacionales. En la reevaluación, la Autodirección ascendió a 45T, normalizando la inserción laboral y logrando abstinencia mantenida de sustancias.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

ALTA HA CON BAJA SD Y RIESGO DE SUICIDIO:

Una puntuación $HA \geq 70T$ unida a $SD \leq 32T$ constituye el perfil de máximo riesgo de desesperanza aprendida y tentativas suicidas impulsivo-reactivas ante frustraciones ambientales.

TEMPERAMENTO OPUESTO (NS ALTA + HA ALTA):

Genera una vivencia subjetiva de continuo 'freno y acelerador simultáneo', altamente desgastante para el paciente, confundible con trastorno bipolar mixto (evaluar ciclicidad).

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Cloninger, C. R., Svrakic, D. M., & Przybeck, T. R. (1993). A psychobiological model of temperament and character. *Archives of General Psychiatry*, 50(12), 975-990.
2. Cloninger, C. R. (1999). *The Temperament and Character Inventory-Revised*. Center for Psychobiology of Personality, Washington University.
3. Gutiérrez-Zotes, J. A., Bayón, C., Montserrat, C., Valero, J., Labad, A., & Cloninger, C. R. (2004). Inventario del Temperamento y Carácter-Revisado (TCI-R): Baremación y datos psicométricos en una muestra normativa española. *Actas Españolas de Psiquiatría*, 32(1), 8-15.
4. Bayón, C., et al. (2014). *TCI-R: Manual del Inventario de Temperamento y Carácter Revisado*. TEA Ediciones.